

Retranscrit 2023 partie 1:

Questions séquences :

X. Un petit de 11 ans tombe sur la paume de la main en jouant, image RX avec un bout d'os arraché au niveau du coude **fracture condyle latéral**.

→ Lésion n. radial
↳ (man. extenseurs du poignet)
↳ "Main tombante"

Quel mouvement de la main à vérifier en premier ?

Extension du poignet

Pour évaluer la fonction du nerf radial, demandez au patient de :

1. Étendre le poignet contre une résistance.
2. Étendre les doigts à partir d'une position de poing fermé.
3. Étendre le pouce.

Questions en plusieurs parties:

Cirrhose
1.a Patiente de 45 ans, avec une consommation d'alcool à 5 verres/jour depuis plusieurs années, se présente aux urgences pour un ballonnement de son abdomen apparu il y a quelque jour. Le ballonnement est assez inconfortable. L'examen physique montre un abdomen distendu légèrement inconfortable à la palpation, avec un niveau hydro-aérique en décubitus dorsal. Pas d'ictère, pas de télangiectasies.

Que faire en premier lieu ?

- ↳ Ascite
car chaque ascite doit faire l'objet d'une ponction diagnostique
- A. Ponction de l'ascite
 - B. Test de l'élasticité du foie
 - C. Doser albumine sanguine
 - D. Doser facteur V, thrombocytes, valeurs hépatiques
 - E. CT injecté

1.b Après avoir ponctionné l'ascite, vous retrouver un liquide clair, coloration Gram négative, gradient albumine sérique/liquide de ponction est à 18g/L. Quelle est la cause la plus probable de cette ascite?

≥ 11g/L
↳ Hypertension portale

- A. Cirrhose hépatique
- B. Hypoalbuminémie
- C. Péritonite
- D. CHC
- E. ...

1.c Vous expliquez à la patiente qu'elle souffre d'une cirrhose hépatique avec hypertension portale et lui conseillez d'arrêter l'alcool. Vous revoyez la patiente 2 ans après qui a été sevrée d'alcool depuis. Elle se plaint de perte de poids, de fatigue et d'ictère en péjoration depuis quelques mois. Vous effectuez un CT qui

montre une masse hépatique au niveau du segment 6 du foie. Le bilan d'extension ne montre pas d'autres lésions et pas de métastases. Que faites vous?

- A. résection segment 6
- B. transplantation hépatique
- C. chimioembolisation
- D. Radiothérapie
- E. Chimiothérapie systémique

1.d Vous procédez à la résection du segment 6. 1 an après, la patiente reviens vous voir pour la péjoration des mêmes symptômes. Vous retrouvez 2 masses au niveau du foie faisant 1.3cm et 1.8cm. Son cas est discuté lors d'un tumor-board. Qu'est-ce qui fait partie des contre-indications à une transplantation hépatique pour cette patiente? (K')

- A. durée trop court de son sevrage d'alcool (Minimum 6 mois sans OH)
- B. nombre de masses
- C. Taille du plus gros nodule
- D. Antécédents de chirurgie hépatique

↳ Critères de Milan : - Tumeur unique < 5cm
ou ≤ 3 tumeurs < 3cm
- Pas d'implication vasculaire
- Pas de métastases

2.a Patient de 78 ans viens vous voir à votre cabinet de médecin généraliste pour un prurit apparu depuis quelques semaines qui est péjoré lors de la douche avec eau chaude. Il présente également des paresthésies au niveau des extrémités, une fatigue, perte de poids et sudations nocturnes. Le laboratoire montre des thrombocytes à 800 et Hb à 220. L'EPO est effondrée. Quelle est l'atteinte ?

- A. Clones de la lignée myéloïde → Thrombocytose et Polycythémie
- B. Hémolyse auto-immune
- C. Lymphome
- D. Splénomégalie

2.b Au vu de son problème, de quoi le patient est-il le plus à risque ?

- A. Asplénie fonctionnelle
- B. Thrombose
- C. Infections

3.a Une mère enceinte de 40SA accouche dans votre service. Elle n'a pas effectué de suivi pendant sa grossesse. Le frottis effectué juste avant l'accouchement était négatif pour le Streptocoque de groupe A. Le bébé naît par voie basse sans complications et s'adapte bien avec un Apgar à 7/9/9. Poids, taille et périmètre crânien >95e. 1h après l'accouchement, le nouveau-né commence à présenter des trémulations, se tortille et pleure beaucoup. Quelle est la première chose à faire?

- A. Mesure de la glycémie
- B. Mesure de l'insulinémie
- C. Mesure de la bilirubine
- D. Mesure de la saturation
- E. Mise au sein de la maman.

Polycythémia Vera
Polyglobulie essentielle
Prurit aquagénique

Diabète gestationnel

3.b Après avoir mesuré la glycémie, vous trouvez une valeur de 1.6 (norme >2.4mmol/L). Que faites-vous?

Hypoglycémie assez sévère

- A. Alimentation précoce avec lait hyperprotéiné
- B. Administration de glucose par sonde naso-gastrique
- C. Solution de glucose en iv** = correction rapide pour le risque de complications (neurologiques)
- D. attente et nouvelle mesure dans 1h.

3.c La mère à vraisemblablement présenté un diabète gestationnel. En plus de la macrosomie, quelle est l'autre complication associée au diabète gestationnel?

↳ Parto malfco. avec le diabète gestationnel

- - cataracte
- - pli palmaire unique
- - Polykystose rénale
- - Retard psychomoteur

Questions K' :

Neuro. GB
1. Patiente avec **diarrhée il y a deux semaines** avec **déficit sensoriel en gant**, **apalleshésie**, **aréflexie** et **perte de force M3 proximale** au niveau des membres inférieurs. Quel examen pour le DX ?

- + - ENMG
- + - PL
- - IRM médullaire
- - CT lombaire

→ J'ai badé et perdu mille ans sur le fait que l'atteinte motrice était proximale du coup j'ai coché IRM médullaire en pensant à une myélite transverse alors que tout le monde a pensé à un GB (certes atypique...) et du coup la rep sûre c'est PL ± ENMG (à vérifier)

Péd.
2. Garçon de **7 semaines** qui **pleure après les tétées** et a **pris très peu de poids** depuis la naissance. Que faire?

- + - Veiller à ce que l'enfant évacue bien l'air après son repas, soit en le portant en position verticale, soit en le couchant pendant quelques minutes à plat ventre
- - Faire une pH-métrie pour rechercher un **reflux gastro-oesophagien**
- + - recommander à la mère de continuer à surveiller la prise pondérale
- ?

Si vomissement: Sténose du pylore
Si p. vomissement: RGO ou intolérance aux protéines de lait

Questions A :

1. Patiente avec retard pubertaire, trop petite et trop grosse pour sa taille, ils donnaient quelques infos sur son stade pubertaire et précisait qu'elle avait un cou palmé :

A. Hypopituitarisme

B. Sd Down

C. Sd de Turner

D. Sd de Klinefelter

(45,XO) Intelligence intacte
(47,XXY)

2. Patient qui consulte car douleurs apparaissent à la marche qui apparaissent après 300 mètres et qui sont empirées lorsqu'il marche en montée et empirée par les changements de position.

A. canal lombaire étroit

B. claudication vasculaire

3. Question sur la raison pour laquelle on doit couvrir par héparine lorsqu'on instaure un traitement par AVK

A. Déficit précoce de la protéine C

B. Une histoire de thrombopénie

4. Patient de 24 ans se présente à votre consultation pour des lésions douloureuses apparue hier.



A. Tinea corporis

B. Infection herpes simplex

C. Impetigo

D. ...

4. Un jardinier de 45 ans se présente à votre consultation avec une lésion apparue il y a quelques semaines au niveau de l'avant-bras. Très prurigineuse au départ, actuellement se plaint surtout de douleur lors de l'exposition au soleil. Pas de notion

de contact à cet endroit ou autres lésions sur le corps. Quel est le traitement le plus approprié en première ligne?



L'image montre une lésion érythémateuse, squameuse et bien délimitée avec des vésicules et une desquamation. La description clinique indique qu'elle est très prurigineuse au départ et actuellement douloureuse à l'exposition solaire. Ces caractéristiques sont compatibles avec une dermatophytose (infection fongique) ou une dermatite de contact.

Cependant, étant donné la forte probabilité d'une infection fongique chez un jardinier, combinée avec les signes cliniques observés, le traitement le plus approprié en première ligne est :

D. Antimycosique

Raisons :

1. Infection fongique probable : Les lésions érythémateuses, prurigineuses et squameuses sont typiques des infections fongiques, surtout chez les personnes exposées à la terre et aux plantes, comme les jardiniers.
2. Traitement ciblé : Les antimycosiques topiques (par exemple, clotrimazole, miconazole, terbinafine) sont efficaces pour traiter les dermatophytoses cutanées.

Explications des autres options :

- A. Vitamine D topique + CS topique : Utilisé pour le psoriasis, mais non approprié pour une infection fongique.
- B. Corticoïdes de classe 3 topique : Les corticostéroïdes peuvent aggraver les infections fongiques en supprimant la réponse immunitaire locale, même s'ils peuvent réduire l'inflammation et les démangeaisons à court terme.
- C. Antibiotique : Indiqué pour les infections bactériennes, mais non pour les infections fongiques.
- E. Inhibiteur de la calcineurine topique : Utilisé pour traiter des dermatoses inflammatoires comme l'eczéma, mais non approprié pour les infections fongiques.

Conclusion :

La lésion présentée par le jardinier est très suggestive d'une infection fongique. Le traitement topique approprié en première ligne est un antimycosique (D), qui ciblera et traitera efficacement la dermatophytose.

- A. Vitamine D topique + CS topique
- B. Corticoïdes de classe 3 topique
- C. inhibiteur ATB
- D. Anti-mycotique
- E. Inhibiteur de la calcineurine topique

Ophth. 5. Patient avec clinique typique de névrite optique (RAPD et déficit visuel) + déficit dans le regard en bas à droite plus œdème papillaire au fond d'oeil, quel examen faire

- A. IRM
- B. PL
- C. CT

Ophth. 6. Patient se présente à votre consultation pour un flou visuel associé à une douleur retro-orbitaires. Elle dit avoir l'impression d'avoir un corps étranger dans l'oeil. A l'examen physique, vous remarquez des œdèmes bilatéraux des paupières, discrète rétraction des paupières et un angle entre la sclère et la cornée de x (au dessus de la norme donnée). De quoi souffre cette patiente?

- A. Lymphome retro-orbitaire
- B. cellulite
- C. Névrite optique
- D. Hypertension oculaire
- E. Maladie ophtalmologique de la thyroïde

Basedow

7. Patient de 34 ans, raconte avoir présenté une vive douleur au niveau de l'arrière jambe lors d'un match de volley. Il dit avoir eu l'impression qu'un de ses coéquipiers lui ait marché sur la jambe alors qu'il n'y avait personne derrière lui. Depuis, douleur au niveau du talon. A l'examen clinique, possibilité de se tenir à la pointe des pieds

mais absence de flexion plantaire passive lors du squeezing du mollet à gauche. Qu'a-t-il?

Test de Thompson

- A. Rupture complète du tendon d'achille
- B. rupture du tendon des long flechisseurs
- C. Rupture partielle du tendon d'achille

8. Patiente de 45 ans avec une fracture du tibia-perroné et cheville très enflée. L'examen physique montre une hypoesthésie au niveau de la commissure du premier orteil et extension des orteils impossible. Mobilité de la cheville n'est pas objectivable en raison de la douleur. Quelle est l'atteinte nerveuse de cette patiente?

- A. Nerf tibial
- B. Nerfs perronier commun
- C. Nerfs perronier superficiel
- D. Nerfs perronier profond
- E. Nerf femoral

9. Un homme se blesse la main droite, et il ne ressent plus de sensations au niveau de l'extrémité de son index et de son majeur, quel nerf est touché?

- A. Nerf radial
- B. **Nerf Médian**
- C. Nerf ulnaire
- D. Nerf interosseux
- E. Nerf axillaire

10. Patiente de 30 ans qui souhaite avoir un enfant mais n'est pas sûre si ses vaccinations sont à jour, ayant beaucoup déménagé quand elle était petite. Selon sa mère, elle n'aurait pas eu de vaccination ROR mais n'est plus sûre. Comment procéder au rattrapage vaccinal chez cette patiente?

- A. vacciner deux doses à un mois d'intervalle
- B. faire une sérologie et vacciner en fonction du résultat
- C. donner une dose et faire une sérologie par la suite pour vérifier séroconversion
- D. Vacciner avec une seule dose
- E. ne rien faire

11. Patient avec plaie au niveau de l'avant-bras, se présente aux urgences avec perte de 15% de volume sanguin. Quel est le premier signe à apparaître?

- A. hypotension
- B. tachycardie
- C. oligurie
- D. Paleur

12. Patient avec cancer prostatique métastatique en **soins palliatifs** à domicile traité par **morphine po**. L'infirmière vous signale qu'il présente des **difficultés respiratoires**.

L'auscultation montre des **râles bi-basaux**. Que faire ?

- A. aspiration bronchique *= Râles agoniques = Râles de mort*
- B. **anticholinergique sc** *↳ sécrétions bronchiques*
- C. restriction hydrique NaCl 1l/j IV
- D. Arrêter tous les traitements
- E. Physiothérapie respiratoire

13. Question sur l'introduction d'**amiodarone** chez un patient en **FA**:

- A. **dose de charge puis un cp par jour**
- B. augmenter graduellement les doses puis 1 cp tous les deux jours
- C. introduire à distance de l'épisode aigu

X. Enfant qui chute à vélo avec **TC sur le bord de la tête**, on retrouve du **sang qui coule de l'oreille (droite)**, **Weber latéralisé du côté de l'oreille qui coule (droite)**

qu'est-ce qui explique au mieux ce saignement:

- A. perforation tympanique
- B. **fracture longitudinale du rocher** *→*
- C. déchirure cutanée du conduit auditif externe

Présentation clinique : Une fracture du rocher peut entraîner du sang dans le conduit auditif externe (CAE) et parfois une otorrhée (écoulement de liquide cérébro-spinal) si la fracture traverse l'oreille moyenne.
 • Lateralisation du Weber : Le test de Weber se latéralise vers l'oreille affectée (droite) en raison de la conduction osseuse améliorée par la présence de liquide ou de sang dans l'oreille moyenne, ce qui est compatible avec une fracture du rocher.
 • Saignement : La fracture peut provoquer un saignement de l'oreille par le CAE en raison de la blessure aux structures osseuses et muqueuses internes.

A. Perforation tympanique :
 • Saignement : Peut causer un léger saignement, mais généralement moins abondant que celui causé par une fracture du rocher.
 • Une perforation seule ne justifie pas forcément la latéralisation du Weber.
 C. Déchirure cutanée du conduit auditif externe :
 • Saignement : Peut causer un saignement limité, mais elle n'expliquerait pas la latéralisation du test de Weber puisque cette lésion ne concerne pas l'oreille moyenne ou interne.

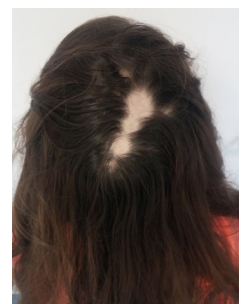
Conclusion :
 La fracture longitudinale du rocher (B) est l'explication la plus probable du saignement et de la latéralisation du test de Weber du côté de l'oreille qui saigne. Ce type de fracture peut causer des saignements importants de l'oreille et entraîner des troubles de l'audition conductive, expliquant la latéralisation du Weber. Une évaluation médicale urgente, incluant un examen otoscopique et des examens d'imagerie (CT scan de la tête), est nécessaire pour confirmer le diagnostic et évaluer l'étendue des blessures.

Développement normal de l'enfant à 3 mois:

- A. **lever la tête à plat ventre**
- B. Peur des étrangers (si si c'était formulé comme ça) *(6-9 mois)*
- C. Tenir assis *(6-8 mois)*
- D. Tenir des objets entre l'index et le pouce *(9-12 mois)*

1. Alopecie chez jeune femme en BSH, pas d'autres symptômes, pas de prurit, quel dx (deux images: une première avec trou de cheveux sans autres signes inflammatoires, puis une nouvelle image quelques semaines plus tard avec de nouvelles zones alopeciques, toujours sans signes inflammatoires, sur la partie postérieure de la tête)?

- A. Teigne
- B. Lichen plan pilaire
- C. **Pelade (alopecia areata)**
- D. Alopecie androgénique
- E. Trichotillomanie



2. Patient de 30 ans présentant des crises de céphalées au niveau frontal-temporal, généralement à gauche. Les crises apparaissent environ 4x/semaine depuis 2 semaines et durent 40 à 60 minutes. Pas de symptômes entre les crises. La partenaire du patient dit avoir remarqué que l'oeil devenait

Dermato

rouge et larmoyant lors de ces crises avec une légère ptose palpébrale. Quel est le diagnostic ?

- A. Céphalées de tension
- B. Cluster Headache**
- C. Neuralgie trijumeau
- D. Migraine avec aura

3. Autre tableau, patient de 37 ans, se présentant aux urgences avec sa compagne, se plaint de céphalées extrêmement douloureuses depuis 3 jours, apparaissant environ 4x/j et qui durent 60' environ. Lors de ses crises, la conjointe dit que le patient court dans tout les sens, transpire excessivement du visage et présente un oeil rouge et larmoyant. Elle dit avoir peur qu'il développe un trouble psychiatrique. Quel est le traitement des crises ?

- A. O2**
- B. Paracétamol
- C. Morphine
- D. Anti-histaminiques

4. (Question mise plus haut) Jardinier de 41 ans avec lésions prurigineuse + qui fait mal au soleil, Photo. Quel TTT ?

- A. Cortico en pommade
- B. Cortico + VitD en pommade
- C. Antiviral
- D. Antimycotique

5. Lésion dans bouche + sur la peau avec photo (peut etre que je confonds les questions, mais je crois que c'était celle la la photo), quel dx ?

- A. Lichen plan**
- B. Psoriasis
- C. Dermatite atopique

Dermato.



6. Patient avec atcd de Tb, présente hypoNA, hypoK, quel test dx ?
- A. Cortisol urinaire
 - B. Stix + sédiment
 - C. **Test à l'ACTH**
 - D. Mesure de Na⁺ et K⁺ dans les urines sur 24h
7. Patiente en BSH qui présente une avec toux sèche+ expecto + et diarrhée acquise depuis 1 semaine après retraite thalasso. Laboratoire montre une hyponatrémie, pouls à 110/min, TA à 90/60mmHg. Auscultation montre une matité inférieure gauche. Quel est le traitement ? (K')
- A. Co-amox + clarithro
 - B. Hospitaliser la patiente
 - C. Expliquer au mari que sa femme est très contagieuse
 - D. Radiographie thorax
8. Patient de 55 ans, hospitalisé pour une pneumonie présente lors de son hospitalisation, une augmentation de ses valeurs de créatinine. Quel traitement faut-il adapter au vu de son insuffisance rénale ?
- A. Amlodipine
 - B. Co-amox
 - C. Acide acétylsalicylique
 - D. zolpidem
 - E. Metoprolol
9. Patiente avec consommation OH ++, voyage beaucoup, très stressée, tabagique, prend pilule et rifampicine et tombe enceinte, pourquoi ?
- A. **Rifampicine**
 - B. Pilule pas 100% efficace
 - C. Décalage horaire
 - D. OH
 - E. Cocaine??
10. Lombalgies chroniques et irradiation dans les deux jambes depuis peu quand marche en descente, douleurs s'arrêtent quand il arrête l'effort. Quel dx ?
- A. **Canal lombaire étroit**
 - B. IAMI
11. Patiente de 55 ans viens vous voir pour demander s'il serait nécessaire d'effectuer un dépistage du cancer du sein. Que lui dire sur la mammographie ?
- A. Spécificité supérieur à 90%
 - B. Sensibilité supérieur à 70%
 - C. Diminue la mortalité dès 50 ans avec le dépistage

- D. Pas d'avantage de la mammographie par rapport à l'auto-palpation mammaire
- E. Recommandé à partir de 40 ans

12. Peintre et plâtrier qui peut plus lever le bras plus haut que sa tête, ce qui est problématique pour son métier, que faire ?

- A. Reclassement par l'AI
- B. Essayer de modifier son taff avant toute annonce à l'AI
- C. Lui faire un certificat médical

13. Après de qui vérifier qu'une entreprise a des conditions ok dans une entreprise ou pleins de employé.e.s ont des problèmes auditifs

- A. Office cantonale ?
- B. SUVA
- C. OFSP
- D. Office fédéral de l'emploi
- E. Office fédéral de l'environnement

14. Patiente de 61 ans, connue pour une maladie de Sjogren et une hypothyroïdie depuis l'âge de 45 ans, traités de façon non optimale en raison d'une non compliance par immunosuppression et lévothyroxine qui vient à votre consultation en raison de chutes à répétition. Elle décrit des paresthésies des deux pieds apparus il y a un an et se plaint de pieds froids, fourmillements et picotements sous les plantes des pieds qui remontent jusqu'aux chevilles. A l'examen clinique, hypoesthésie tacto-thermo-algique en chaussette, pallesthésie à 6/8 aux genoux, 4/8 aux chevilles, hyporéflexie rotulienne, aréflexie achilléenne, Romberg positif à la fermeture des yeux, marche instable. Ce tableau suggère en premier lieu:

- A. Une polyradiculoneuropathie démyélinisante inflammatoire aigue de type Guillain-Barré
- B. Une mononeuropathie multiple vasculitique en lien avec les maladies immunitaires dont elle souffre
- C. Une polyneuropathie longueur-dépendante axonale chronique
- D. Une myélopathie cervicale compressive
- E. Des séquelles d'un AVC

15. Patiente présente baisse de l'acuité visuelle, douleurs à la mastication, papilloedème et diminution du champ visuel latéral, que faire ?

- A. VS + CRP
- B. Biopsie de l'artère temporale
- C. IRM cérébrale

16. Patiente ayant eu un cancer du sein il y a 12 ans qui a été traité par mastectomie et radiothérapie. Elle présente actuellement une instabilité à la

marche et des vertiges. A l'examen physique, le Romberg est altéré et il y a un déficit thermo-algique. Elle présente également une hyperréflexie, prédominante au niveau des membres inférieurs. Quel est le diagnostic ?

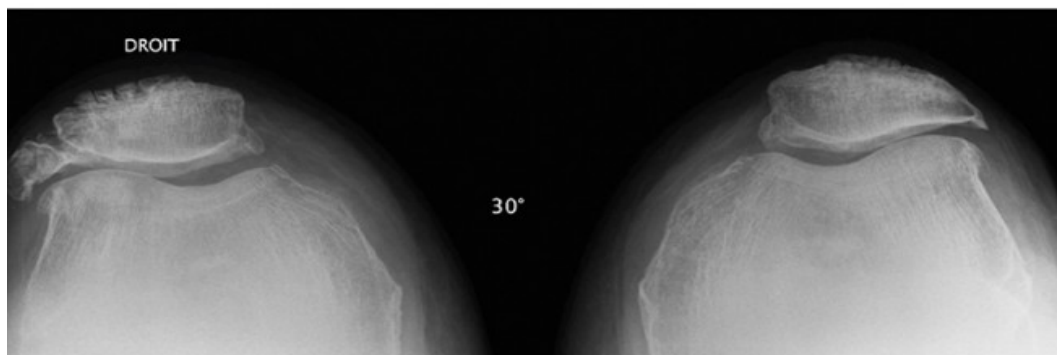
- A. Métastase cérébrale
- B. Myélopathie postérieure

17. Radio de genou (arthrose), quel autres examens ?

- A. RX obliques
- B. CT
- C. IRM
- D. Pas d'autres examens nécessaires

18. Dx ?

- A. arthrose femoro-patellaire
- B. Faiblesse du muscle fémoral
- C. Tendinite du tendon rotulien



19. Enfant de 12 ans (?) tombe sur épaule et rx avec fracture et lésion lytique ovale, Dx le plus probable ?

- A. Sarcome d'Ewing
- B. Ostéosarcome
- C. Langerhans cell histiocytosis
- D kyste osseux benin

NB : c'était plus ou moins ça mais avec une fracture



20. Enfant de 7A, rotation interne de la hanche douloureuse, quel dx ?

- A. Epiphysiolyse
- B. Synovite transitoire de la hanche
- C. Fracture
- D. Perthes

21. Jeune homme de 12 ans, 177cm, 78kg, douleurs de temps en temps au genou, quel dx ?

- A. Epiphysiolyse
- B. Ostéochondrite disséquante
- C. Déchirure du ménisque latéral
- Arthrite juvénile idiopathique

22. Eruption cutanée sur le fesses, image avec vésicules en bouquet, quel dx ?

- A. Parvovirus B12
- B. **HSV**
- C. Impetigo

23. Enfant avec EF depuis 3 jours, maux de gorge + erythème qui épargne région péribuccale, paumes et plantes, quel dx ? Photo de l'éruption sur le dos du kid

- A. **Scarlatine**
- B. Mégalérythème infectieux (5^{ème} maladie)
- C. Kawasaki
- D. Roséole

24. Homme obèse de 40-50ans (mais sans ATCD je crois) qui fait une syncope à l'importe pièce au supermarché. Revient à lui très vite sans déficit neuro, ne se tape pas la tête. Puis reperd connaissance. A l'arrivée du 144 y a un BBD nouveau a l'ECG, extrémités clampées et froides, quel dx ?

NB : ils donnaient une gazo et les paramètres je crois

- A. EP
- B. Choc septique
- C. Infarctus
- D. Dissection carotidienne

25. Patient qui consulte aux urgences car a perdu conscience assis, sans prodromes, perte d'urine, ne se souvient pas de la chute, que faire ?

- A. ECG en continu
- B. EEG
- C. Schellong
- D. Suivi des paramètres cardiaques
- E. taux d'Alcoolémie (c'est pas cool).

26. Epilepsie >20 min, que faire ? (CF tous les retranscrits)

- A. Acide valproïque PO
- B. BZD + levetiracetam IV
- C. CT
- D. EEG

27. Patient qui a perdu 6kg sans faire exprès, ne mange plus, dort mal, ne voit plus ses amis ni sa famille, même pas son petit fils de 1 an qu'il se réjouissait de voir. Tout ça dure depuis 1M. Quel dx ? Question menu long

=> Episode dépressif

30. Patient se présente aux urgences pour dyspnée et DRS. Il a de la mousse a la bouche et une TA 220/110. Quel dx ?

- A. STEMI
- B. Crise hypertensive
- C. Dissection aortique
- D. Infarctus du myocarde étendu
- E. Embolie pulmonaire centrale

31. ECG d'une patiente qui fait décompensation cardiaque gauche : FA vs BAV

32. ACR avec AESP, quelle prise en charge ?

- A. Ephedrine
- B. Adrénaline
- C. Défibrillation
- D. Norephedrine
- E. Noradrénaline

33. Vous arrivez sur le lieu d'un accident de la route, jeune homme BSH très algique mais toujours incarcéré dans sa voiture, vous n'avez pas d'accès veineux, quel hypno-inducteur lui donnez-vous?

- A. Etomidate
- B. Propofol
- C. Ketamine
- D. Sevoflurane
- E. Isoflurane

34. Comment savoir qu'on est au bon endroit pour rachianesthésie ?

- A. Perte de résistance
- B. Paresthésies MI
- C. **Retour LCR**

36. Homme retrouvé dans la rue avec bradypnée et myosis, quelle intoxication ?

- A. BZD
- B. Alcool
- C. **Opioïdes**
- D. Cocaïne

37. Hyperglycémie (36mmol) + hypokaliémie à 2.2, on donne NaCl 0.9 et ?
- A. Nacl hypertonique
 - B. NaBic
 - C. KCl
 - D. Insuline IV
40. Mec avec urétrite, qu'est ce qu'on cherche pour le diagnostique ? K'
- A. Syph
 - B. VIH
 - C. Gono
 - D. Chlamydia
41. Femme de 35a, 35UPA, atcd MTEV, necrose des doigts + orteils avec plaies noires sur articulations, quel dx ?
- A. Thrombose artérielle oblitérante
 - B. Thrombose veineuse
 - C. Thromboangiopathie oblitérante
42. Quels examens pour dx Guillain-Barré ? K'
- A. ENMG
 - B. PL
 - C. IRM
 - D. CT
47. Hypoesthésie pulpe index et majeur, quel nerf touché ?
- A. Median**
 - B. Ulnaire
 - C. Radial
 - D. Axillaire
 - E. Musculo-cutané
48. Thrombopénie, Anémie, leucocytose et ADP + photo histo avec ombres de Gumprecht, quel dx ?
- A. LLC**
 - B. CMV
 - C. HIV
 - D. La réponse D
49. Pancytopenie + ADP chez un jeune de 22 ans, que faire ? Image histo avec PMN normaux.
- A. Sérologie EBV
 - B. Sérologie CMV
 - C. Biopsie d'une adénopathie
 - D. Virémie VIH

E. Ponction-biopsie de moelle

50. Pneumonie post immunosuppression, cavernes à la RX, image histo avec hyphes, quel agent infectieux ?
- A. Pneumocoque
 - B. **Aspegillus**
 - C. tuberculose
 - D. Cryptocoques
51. Homme d'une cinquantaine d'années qui se plaint de douleurs au dos, CRP 10, pas de leuco, pas d'anémie, pas d'IR, calcémie normale, prend des cortico, quel dx ?
- A. Spondylodiscite
 - B. **Ostéoporose**
 - C. métastase de cancer de la prostate
 - D. Myélome multiples
52. Homme avec prurit anal, où trouver les œufs du parasite ?
- A. Dans les poumons
 - B. Dans les selles
 - C. Dans le colon
 - D. **Sur l'anus**
53. Femme de 56 ans avec atcd d'hystérectomie avec conservation des ovaires, présente des symptômes de ménopause, quels exa faire ? K'
- A. FSH
 - B. Oestrogènes
 - C. a-17-OH-progestérone
54. Suite de la question : il s'agit bien d'une ménopause, quel ttt pour cette patiente ? K'
- A. **Oestrogènes**
 - B. Oestrogènes + progestatifs
 - C. **Hygiène de vie**
 - D. **Phytothérapie**
55. Jeune femme se présentant au cabinet avec des symptômes dépressifs depuis 3 jours+ idées suicidaires depuis rupture il y a une semaine, quel dx ?
- A. trouble adaptation
 - B. trouble de la personnalité labile
 - C. Trouble dépressif sévère
 - D. Trouble dépressif léger

56. Tableau de SLA, quel DX

- A. SLA
- B. SEP
- C. Sequelles AVC

57. Douleurs abdo, image d'un CT low dose quel dx ?

- A. lithiase urinaire**
- B. lithiase biliaire
- C. appendicite



58. Menu long : trauma, diminution MV et baisse de la transmission des vibrations sur une plage pulmonaire -> pneumothorax

59. Menu long : douleur irradie vers épaules -> pancréatite

60. Prise en charge trauma puis soudain instabilité hémodynamique avec turgescence jugulaire, que faire ?

- A. ETT
- B. drain thoracique**
- C. drain péricardique
- D. CT
- E. RX

61. Saignement vaginaux post ménopause, endomètre épaissi, que faire ?

- A. biospie**
- B. hystérectomie
- C. contrôle dans 3mois

62. Enfant avec fesses rouges après diarrhées, crème de zinc n'aide pas, quel pb ?

- A. candida**
- B. Dermatite atopique
- C. Dermatite de contact
- D. Staphylocoque

63. Enfant de 6 mois, toussé depuis 3 semaines, muguet oral et vaginal, quel diagnostic à exclure ?

- A. muco
 - B. déficit en anticorps
 - C. déficit immunitaire combiné
 - D. Coeliakie
- Rep C ?

64. 7A, vomissements alimentaires puis biliaires, pas de sang dans les selles, RX avec anses dilatées, quel dx ?
A. Hirschsprung
B. Volvulus
C. Invagination
65. OMI causés par quel médicament que le patient prend ?
A. Nifédipine
B. Metoprolol
C. Metformine
D. Enalapril
E. Amlodipine
66. Patiente avec perte de poids, intolérance à la chaleur, tachycardie, quel traitement pendant qu'on cherche le dx ?
A. Carbimazole
B. b-bloquant
C. Propylthiouracile
67. Patiente avec exophthalmie et pas d'autres symptômes, quel dx (cf plus haut) ?
A. Thyroïdien
B. Lymphome rétro-bulbaire
68. Patiente de 23 ans présente RAPD, diminution vision couleur, quel examen pour dx ?
A. IRM cérébrale
69. Patiente qui prend des statines, a déficit de force M5 + erythème lila des paupières, quel dx ?
A. Sclérodémie
B. Dermatomyosite
C. Effet indésirable des statines
70. Diplopie le soir, pas de diplopie quand vous voyez la patiente le matin, quel dx ?
A. Myasthénie
B. Strabisme
C. Myopie
D. L'ophtalmo c'est nul
71. Patient qui présente diplopie à l'abduction de l'œil gauche, paralysie faciale gauche et déviation de la luette, quel dx ?
A. AVC ischémique
B. Polynévrite

- C. Paralyse supranucléaire
- D. Paralyse de Bell

72. Patiente avec œdème, chaleur, rougeur sous l'angle de la mandibule, ne peut pas ouvrir la bouche plus que 15mm, quel dx ?

- A. Sialadénite
- B. Sialolithiase
- C. Abscess sous mandibulaire**
- D. Adénite

73. Patiente diabétique présente jambe rouge, chaude, oedématisée avec crépitements à la palpation, quel dx ?

- A. Erysipèle
- B. Gangrène gazeuse?**
- C. Fasciite nécrosante ?**
- D. Dermo-hypodermite

74. Patient développe douleurs à la cheville 6 semaines après trauma, RX de contrôle à 6 et 12 semaines normales. Douleurs de temps en temps, pas d'EF, cheville rouge, chaude et oedématisée. Quel dx ?

- A. Arthrite septique
- B. Syndrome douloureux régional complexe
- C. Thrombose veineuse

Rep B ?

75. Patiente qui consulte aux urgences car faible, EF. On découvre un souffle diastolique 4/6. Des hémocultures sont prélevées, que faire en premier ?

- A. Echocardiographie
- B. RX
- C. Antipyrétiques et antibiotiques**
- D. RAD avec tt antipyrétique

76. Patient vient aux urgences car DRS qui irradient dans le dos, TA à 170/80 et 150/.. (ça change la donne pour la réponse parce qu'il est stable) différente aux deux bras, FC 90, quel prise en charge ?

- A. Echocardiographie transthoracique
- B. OGD
- C. CT injecté**
- D. RX
- E. Troponine

77. Patient avec régurgitation mitrale modérée sans prolapsus, va faire un détartrage, quelle prophylaxie ?

- A. Pas de prophylaxie antibiotique

- B. Amox 1g avant
 - C. 1amox 1g avant + 1g après
 - D. CoAmox 1g avant
 - E. Coamox 1g avant + 1g après
- REp A ?

Réponse B? Patient à haut risque d'endocardite

<https://ansm.sante.fr/uploads/2021/02/04/reco-prescription-des-antibiotiques-en-pratique-buccodentaire-septembre2011.pdf>

78. Petite fille de 6 ans vient aux urgences pour un mal de gorge qui s'est installé il y a 3 jours, avec un état fébrile 38.5°C et refuse de manger et de boire. Ce matin, elle bavait beaucoup et sa mère a remarqué que sa voix avait changé.

Contre quel pathogène doit on vérifier la vaccination?

- A. Strepto pneumoniae
- B. Coxellia Burnetti
- C. Hémophilus Influenzae type B
- D. Mycoplasmos tuberculosis
- E. Bordetella pertussis

79. Quelle étude pour définir l'efficacité d'un nouveau traitement pour le sevrage tabagique ?

- A. Cas-contrôle
- B. randomisé-controlé**
- C. Cohorte
- D. rertospective

80. Avec quelle étude prouver le lien entre mésothéliome et amiante ?

- A. Cas-contrôle
- B. randomisé-controlé
- C. Cohorte
- D. rertospective
- E. Transversale

Rep A

81. Dysplasie du col de l'utérus (CIN3), quelle prise en charge ?

- A. Controle et frottis dans 3 mois
- B. conisation
- C. hystérectomie

82. Femme a des vertiges déclenchés par le mouvement, quelle est la cause ?

- A. lithiases dans les canaux semi-circulaires
- B. hydrops endolymphatique
- C. Elle est bourrée H24

83. Patient hospitalisé il y a 1 an pour accident, présente depuis 2 mois un changement de voix,..?

Si quelqu'un veut retranscrire celles là : have fun

29. Patient agé (?) avec dysphagie, et avec image de stase dans l'œsophage distal, Dx ?

- A. carcinome oesophagien
- B. carcinome sous-muqueux de l'oesophage
- C. tumeur extrinsèque
- D. achalasie

8. 2 personnes dans accident de voiture, homme et femme, on sait pas qui conduit, le mec meurt sur place et la femme est évacuée (mais genre glasgow pas top). En tant que médecin légiste vous devez (elle est dans d'autres retranscrits si jaja)

- A. Identifier les personnes avec leur ADN (qqch du genre)
- B. Examen forensique des lésions sur le corps de la femme
- C. Doser l'alcool dans le sang de la femme
- D. Doser les toxiques dans le sang du monsieur décédé

43. Question presque identique à celle-ci :

144) Question en deux parties (pour avoir la deuxième partie il faut verrouiller la première)

144.1 : Nouveau né de 2j qui est né à terme après grossesse harmonieuse, bonne adaptation néonatale avec un APGAR à 9/10/10, mère groupe O, Rhésus +, d'origine méditerranéenne. Contrôle de la sage femme : ictère prononcé, sinon nouveau-né qui va bien. La mère dit que l'ictère a débuté la veille. Qu'est ce qui est la raison de l'ictère ?

-
- A) Immaturité hépatique
 - B) Incompatibilité ABO
 - C) Thalassémie
 - D) incompatibilité rhésus

144.2 :

Au vu de l'ictère précoce, la sage femme fait la bilirubine qui est à 320 (norme <220). Quel test supplémentaire doit-elle envoyer au pédiatre ? (K')

- A) Hémoglobine
- B) Électrophorèse de l'hémoglobine
- C) Coombs
- D) Tests hépatiques

46. Fracture de l'humérus distal, faire gaffe a quel nerf
Diversification alimentaire pour éviter allergies

50. gonarthrose bilatérale

51. arthrite juvénile vs epiphysiolyse vs nécrose avasculaire

53. photo nez d'un patient -> furoncle

54. paralysie faciale fait quoi comme symptôme

X. Une mère avec un diabète gestationnel non identifié pendant la grossesse accouche d'un gros bébé. A part la macrosomie quelles sont les autres complications pour le nouveau né?

- A. Cataracte
- B. Polykystose rénale
- C. Dysraphisme spinal = *Spina bifida*
- D. Pli palmaire
- E. Polydactylie

X. Un patient en soins palliatifs reçoit de la morphine 1 mg toutes les heures. La demi-vie de la morphine est de 3h. La dose est maintenant augmentée à 2mg/h. Quel est le meilleur moment pour mesurer le taux d'action ? (type A)

- A. Après 30 minutes
- B. Après 1h30
- C. Après 4h
- D. Après 12h
- E. Après 24h

X. Une patiente de 60 ans avec une hypertension connue a été bien contrôlée par son médecin généraliste avec un bloqueur des récepteurs At1 et un diurétique. En raison d'une polyarthrite rhumatoïde, elle prend un AINS (naproxène 250 mg) depuis 8 semaines. Sa tension artérielle est maintenant de 150/90 mmHg.

Comment faut-il la traiter ?

- A. Arrêter le naproxène
- B. Remplacer le bloqueur AT1 par un inhibiteur de l'ECA.
- C. Bêta-bloquant
- D. Arrêter le naproxène, commencer les médicaments biologiques et garder le métamizole en réserve.
- E. Remplacer le naproxène par du diclofénac

X Radio thoracique avec pleins de petits foyers dans les poumons. ATCD de cancer du sein en rémission. Keskessé ?

- A. Tuberculose
- B. Pneumonie multisp
- C. Métastases
- D. Emboles septiques



X. Une mère vient à votre consultation avec un BB qui pleure non-stop. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours et dit qu'elle ne peut pas faire une nuit de plus. Elle n'a personne dans son entourage. Que faites-vous?

- A. Encourager à demander de l'aide aux voisins
- B. Envoyer à la consultation parentale
- C. La revoir le lendemain
- D. Hospitalisation de répit
- E. Rassurer la mère que c'est un processus normal

X. Un patient avec cancer métastatique et en soins palliatif reçoit de la morphine pour ses douleurs accompagné d'un laxatif. La morphine soulage ses douleurs mais il se plaint de cauchemar et d'hallucination

- A. Changer morphine pour hydromorphone
- B. Arrêt morphine.
- C. donner lorazépam le soir
- D. Donner de l'haldol 3x/j
- E. X

X. Patient avec pleins de complication souhaite une dialyse malgré le fait que l'équipe médical ne pense pas que cela ait de bénéfice. Sa famille vous dit que si vous faites pas de dialyse elle vous fait un procès.

- A. Vous le faites par peur du procès
- B. Vous le faites parce que la famille soutien le projet
- C. Vous le faites parce que vous respectez l'autonomie du patient
- D. Vous le faites pas en utilisant le principe de "futility"

X. Une personne chute sur le côté et a un écoulement de sang de l'oreille. Quelle peut être la cause

- A. Fracture du rocher
- B. Rupture de tympan
- C. lésion du conduit auditif

Je sais plus le cas clinique. Que vous attendez vous à voir chez ce patient

- A. Infections
- B. Asplénie fonctionnelle
- C. Truc myélo

Masse sous-mandibulaire rouge et chaud depuis quelques jours avec trismus

- A. Sialolithiase
- B. Abscess sous-mandibulaire
- C. Cancer

séro HBV: HBs antigé anti-HBs + avec un taux anti-HBs élevé, anti-HBc IgM/IgG +

- A. Infection HBV aigue

- B. Couverture vaccinale HBV, suffisante
- C. Couverture vaccinale HBV insuffisante
- D. Infection HBV chronique inactive
- E. Infection HBV guérie

Une patiente de 45ans se présente à votre consultation. Il y a quelques mois, elle souffrait d'attaque de panique avec sensation de dyspnée, oppression thoracique et peur de mourir. Elle a été mise sous BZD max 3x/j par son médecin traitant. Ce traitement a permis de maîtriser et de résoudre les attaques de panique.

Actuellement, elle vient vous consulter car elle se sent de plus en plus triste depuis quelques semaines. Elle a perdu du poids involontairement, dort mal et a perdu l'appétit. Les activités qui auparavant lui procuraient du plaisir la laissent désormais indifférente. Elle vous confie également que les attaques de panique ont refait leur apparition, sous la même forme, et que le traitement de BZD se montre inefficace. Quelle est la suite de la prise en charge ?

- A. Diminution progressive des Benzodiazépines et commencer un ISRS
- B. Poursuite des Benzodiazépines et commencer un ISRS
- C. Arrêt des Benzodiazépines et commencer un ISRS
- D. Débuter une thérapie cognitivo-comportementale

Réponse A ?

FA
Une femme de 74ans arrive aux urgences avec une dyspnée et des palpitations survenue il y a quelques heures. Avec l'ECG, vous diagnostiquez une FA rapide décompensée. Vous décidez pour cela de tenter une **cardioversion médicamenteuse**. *car FA de <48h*

Quel est le traitement approprié ?

(>48h: β-B et Anticoag.)

- A. Amiodarone posologie classique 1x/j
- B. **Amiodarone dose de charge puis posologie classique 1x/j**
- C. Amiodarone dose réduite puis posologie classique 1x/j
- D. Amiodarone posologie classique 1x tous les 2j
- E. Amiodarone dose réduite puis posologie classique 1x tous les 2j

Réponse B (dose de charge pour imprégnation du myocarde, puis posologie N)

RH. Une mère vient à votre consultation pour un retard de croissance de sa fille de 13ans. Sa fille présente un poids >95e percentile, une taille <5e percentile, et un PC 50-75e percentile. Vous trouvez à l'examen un goitre diffus et un cou palmaire. Les stades de Tanner sont P1 et S2. Le laboratoire montre une euthyroïdie.

Quelle est votre suspicion diagnostic ?

- A. Sd Turner (X0)
- B. Un retard constitutionnel de croissance
- C. Une hypothyroïdie
- D. Une hypertrophie congénitale des surrénales
- E. Malabsorption

Reponse A

Une femme de 37ans, diabétique de type 2 traitée par insuline, se rend aux urgences pour une pollakiurie, polydipsie, faiblesse générale. Son laboratoire montre :

- Hyperglycémie à 30
- Hypokaliémie à 2.2 (sévère)
- Hypomagnésémie
- pH à 7.25

Une perfusion de NaCl est mise en place. Que faire en premier par la suite :

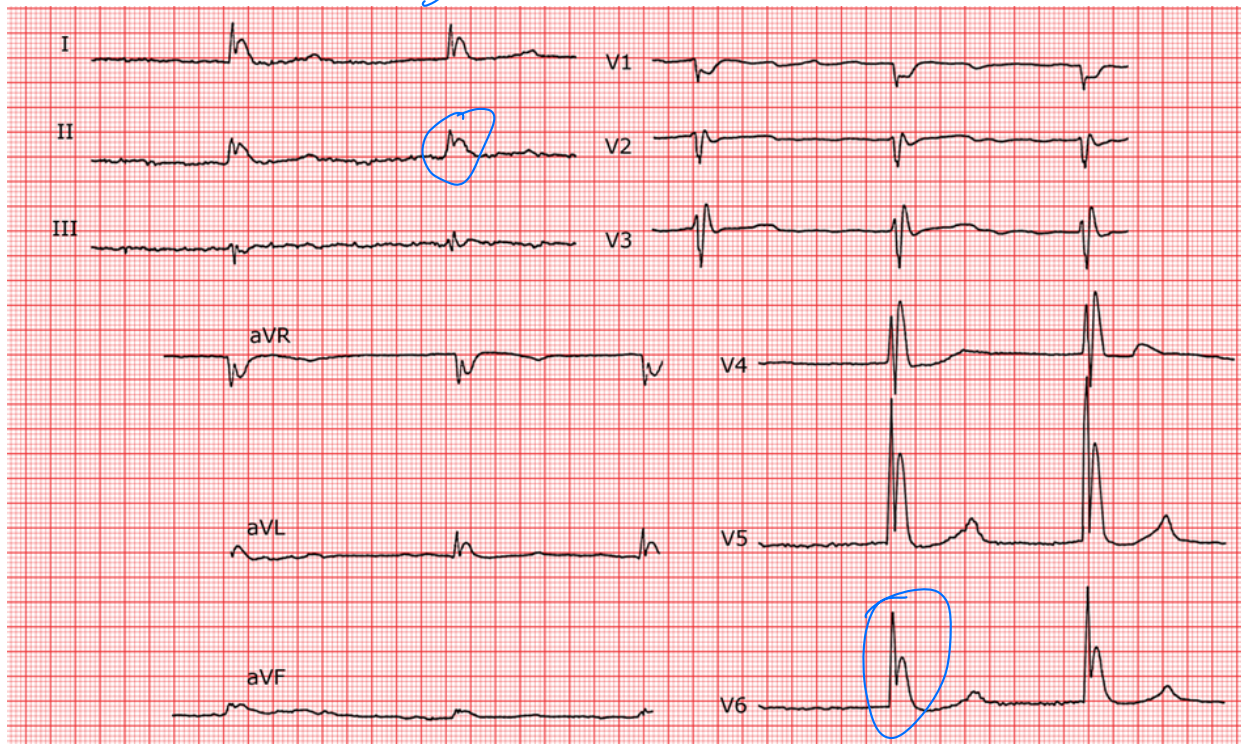
- A. Insuline IV
- B. Chlorure de potassium IV
- C. Na-Bic IV
- D. Solution hypertonique NaCl 3.0%
- E. Calcium IV

Réponse B (KCl IV en 1e, si insuline avant, aggravation hypoK)

Une dame d'une cinquantaine d'années est retrouvée sur un banc à 5h du matin au mois de Février. Elle est amenée aux urgences, vous retrouvez une dame en GCS 3/15. On vous montre son **ECG** :

Hypokaliémie

" } Osborne "



Quelle mesure prendre pour confirmer le diagnostic :

- A. Coronarographie
- B. Mesure de la température œsophagienne
- C. Mesure de la kaliémie (hypokaliémie)
- D. Echocardiographie
- E. CT thoracique injecté

Réponse B (ondes d'Osborn à l'ECG)

Une mère se rend à votre consultation avec son nouveau-né de 3 mois, elle s'inquiète par rapport à son développement psychomoteur. Qu'est-ce qui est correct par rapport au développement d'un enfant de cet âge là ?

- A. Il peut attraper des objets entre son pouce et son index
- B. Il peut se tenir seul assis
- C. Il est capable de relever la tête lorsqu'il est allongé sur le ventre
- D. Il a peur des étrangers
- E. Il est capable de se retourner de lui-même (passer d'une position sur le ventre à une position sur le dos)

Réponse C

Une femme de 77ans se présente aux urgences avec une dyspnée. Elle revient d'une thalassothérapie de 5j.

FR 30/min, TA 90/70, FC 110/min, SaO2 90% AA. À l'auscultation, vous entendez des râles en base droite. Le reste du status est dans la norme.

Son laboratoire montre :

- Hyponatrémie
- Hb 112g/L
- Créatinine légèrement augmentée
- Urée augmentée

Suite de la PEC (K') :

- A. Amoxicilline-clavulanate + Clarithromycine
- B. Hospitalisation
- C. Dire à son mari que la transmission interhumaine est possible
- D. Radiographie du thorax

Réponses : + + - +

Vignette 1.1.

Vous êtes appelé pour un nouveau-né de 3h dont l'adaptation néonatale était correcte (APGAR 7/9/10). Il est né à terme, avec césarienne pour une dystocie des épaules. Son poids est >95e percentile, sa taille >95e percentile et PC 50e percentile. La mère n'a pas bénéficié de suivi durant sa grossesse.

Actuellement le nouveau-né est apathique, ne pleure pas et ne répond que peu à la stimulation. Quelle est la prochaine mesure à prendre :

- A. Mesure de la bilirubine
- B. Mesure de l'hémoglobine
- C. Mesure de la glycémie
- D. Mesure des gaz sanguins

E. Mesure des électrolytes

Réponse C

Vignette 1.2.

Un diabète est diagnostiqué chez la mère. Le nouveau-né montre une hypoglycémie à 2.2. Quelle mesure prendre ?

A. Dextrose IV

B. Glucose 10% IV

C. Glucagon

D. Solution hypertonique

E. Alimentation précoce

Réponse E

- Vignette 2.1.

Nouveau-né de 2 jours, né à terme après grossesse harmonieuse, bonne adaptation néonatale avec un APGAR à 9/10/10, mère groupe O, Rhésus +, d'origine méditerranéenne. Le contrôle de la sage-femme montre un ictère prononcé, sinon nouveau-né qui va bien. La mère dit que l'ictère a débuté la veille. Quelle est la raison de l'ictère ?

A) Immaturité hépatique

B) Incompatibilité ABO

C) Thalassémie

D) incompatibilité rhésus

Réponse B (cause principale des ictères pathologiques du NN : incompatibilité ABO

<https://www.paediatricschweiz.ch/fr/recommandations-pour-la-prise-en-charge-des-nouveaux-nes-presentant-une-hyperbilirubinemie/>)

- Vignette 2.2.

Au vu de l'ictère précoce, la sage-femme fait la bilirubine qui est à 320 (norme <220). Quel test supplémentaire doit-elle envoyer au pédiatre ? (K')

A) Hémoglobine

B) Électrophorèse de l'hémoglobine

C) Test de Coombs

D) Transaminases

ses Réponses : + - + -

(<https://www.paediatricschweiz.ch/fr/recommandations-pour-la-prise-en-charge-des-nouveaux-presentant-une-hyperbilirubinemie/>)

Lors d'un CT abdo pour un patient avec diverticulite sigmoïdienne, vous découvrez une masse au-dessus du rein. Vous n'avez pas d'autres infos. Qu'est-ce que c'est?

- A. Adénome du cortex surrénal
- B. Carcinome du cortex surrénal
- C. Myélolipome
- D. Phéochromocytome non sécrétant
- E. Métastase

Réponse A

Une patiente de 70ans avec Parkinson est hospitalisée pour une pneumonie d'aspiration. Quelle est la meilleure stratégie concernant l'alimentation ?

- A. Nutrition par SNG
- B. Nutrition parentérale
- C. Epaississement des liquides
- D. Suppléments alimentaires

Réponse C

Vous suivez une patiente de 70ans avec cancer du sein et carcinose péritonéale. Elle se plaint actuellement de nausées, déclenchées par l'odeur des repas et soulagée par l'air frais. Ses douleurs sont bien gérées par de la Morphine, elle présente un transit régulier. Concernant la prise en charge de votre patiente, quel est le meilleur choix actuellement ?

- A. Augmentation de la morphine
- B. Augmenter les laxatifs
- C. Gestion du traitement anti-nauséeux
- D. X
- E. X

Réponse C

Patiente de 25ans se présente à votre consultation pour une diplopie survenue la veille. Actuellement la diplopie n'est plus présente. Lorsque vous faites regarder la patiente vers le haut, vous remarquez une chute de la paupière supérieure survenant après une dizaine de secondes. Diagnostic ?

- A. Dermatomyosite
- B. Myasthénie oculaire
- C. Accident vasculaire cérébrale

D. Névrite optique

Réponse B

Vous voyez un attroupement près de la gare, au milieu se trouve un individu d'une trentaine d'années apparemment inconscient. Vous ne parvenez pas à le réveiller, vous remarquez qu'il est bradypnéique et que ses pupilles sont anormalement rétrécies. Intoxication ?

- A. Alcool
- B. Cocaïne
- C. Cholinergique
- D. Héroïne
- E. Amphétamines

Réponse D

Vignette 3.1

Un patient de 55ans présente des DRS et une dyspnée. A la formule sanguine, vous retrouvez une hématokrite à 60% et des thrombocytes à 550G/L (norme 150-350G/L). Une analyse montre JAK2+. De quoi votre patient est-il atteint ?

- A. Une leucémie lymphoïde chronique
- B. Un myélome multiple
- C. Une prolifération monoclonale de la lignée myéloïde
- D. Un lymphome

Réponse C

Vignette 3.2

Vous diagnostiquez une polycythémie verae. Quelle est la démarche à entreprendre ?

- A. Prophylaxie thrombo-embolique
- B. Coronarographie
- C. CT-scan thoraco-abdominal
- D. Hydratation (?)

Réponse A

Patient de 3 ou 5 ans qui présente des amygdalites à répétition, une amygdalectomie est indiquée. Quelle est la complication la plus fréquente ?

- A. Hémorragie.
- B. Infection
- C. Troubles du goût

Patiente de 5 ans avec plein d'aphtes dans la bouche qui l'empêche de manger, quel traitement?

- a. acyclovir

- b. fluconazol
- c. co-amox
- d. amphotéricine B
- e. prise d'antalgique avant les repas

(Pas le ttt causal pour les aphites)

=> je crois que finalement c'est la E mais j'en avais aucune idée...

BB de quelques semaines (genre 7) qui présente une candidose bouche et vulvaire depuis presque la naissance et autres pathologies infectieuses (je sais plus lesquelles) qu'est-ce que ce BB a probablement?

- a. Un déficit en anticorps -> plus souvent lié à l'X et plus tard (quelques mois quand plus les atc maternels)
- b. **Un déficit immunitaire mixte** -> c'est ce qui paraissait le plus logique
- c. Mucoviscidose
- d. .

28. Patiente d'environ 30 ans BSH qui avale de travers un bout de roastbeef, elle n'a pas pu terminer son repas, car elle vomissait tout. Elle vient aux urgences, car maintenant elle a une sensation d'oppression thoracique. Pas de dyspnée, pas de tachypnée, PV dans la norme (il me semble).

Quel examen effectuer?

- A. Demander un avis ORL
- B. Transit baryté oesophagien
- C. Gastroskopie
- D. CT
- E. Bronchoscopie

Patiente avec plusieurs comorbidités, hospitalisée pour pneumonie, qui développe une IR avec eGFR < 30 ml/min. Quel médicament doit-être adapté?

- A. Aspirine
- B. Co-amoxicilline
- C. Anticalcique
- D. IEC
- E. X

Enfant d'environ 7 ans qui était propre mais présente une énurésie diurne depuis quelques semaines. Le père explique qu'on a diagnostiqué un cancer chez la mère et que le pronostic est encore incertain. L'enfant dessine et dit rien, mais vous écoutez discuter avec le père. Que proposez-vous?

- A. Calendrier miction
- B. Restriction hydrique

- C. Explorer ce que l'enfant a compris de la situation, comment il se sent par rapport à ça
- D. L'envoyer en psychothérapie

Réponse : C

2023 : JOUR 2

124. Le corps d'un homme de 80 ans est retrouvé dans un appartement locatif. Un chauffage individuel à gaz se trouve dans la même pièce. Les secouristes ont déjà ouvert les fenêtres. Le médecin de garde constate une rigidité résolue et des lividités fixées. Il n'y a pas de tâche verte ni de décollement de l'épiderme. Quel examen supplémentaire confirmera le diagnostic?

- A. Des lividités rouges claires
- B. Des vomissures à proximité du corps
- C. ...?
- D. Une odeur de pomme mûre émanant du corps
- E. Une odeur d'amande amère émanant du chauffage

K' Vous êtes médecin légiste appelé sur les lieux d'un accident de voiture. Vous retrouvez la voiture complètement détruite avec deux corps à côté de la voiture, l'homme du côté conducteur et la femme du côté passager. L'homme décède sur place et la femme est transportée aux soins intensifs (je suis plus sûre) Que faire :

- A. Prélever l'ADN des deux personnes
- B. Doser l'alcoolémie chez la femme
- C. Faire une recherche de toxiques chez les deux individus
- D. Examen forensique de la femme

A Un patient avec un antécédent de plastie de la valve mitrale qui va chez le dentiste. Prophylaxie antibiotique:

- A. Ne rien faire
- B. 2g de co-amoxicilline 1h avant le traitement
- C. 2g de co-amox 1h avant et 2h après le traitement
- D. 500mg/j pendant une semaine avant l'intervention de co-amox
- E. ?

A Homme souffrant d'obésité morbide sans antécédent particulier (il me semble, ou alors diabète + tabac) d'une soixantaine d'années qui fait un malaise dans un supermarché. Au moment de l'arrivée des secours, bradycarde, hypotendu, extrémités chaudes et parvient à répondre à la parole. Quand arrive à l'hôpital, trouble de l'état de conscience. Origine du choc la plus probable?

- choc septique
- Choc obstructif
- Choc cardiogénique
- Choc anaphylactique
- Choc hémorragique

Vous êtes au bord du lac quand vous remarquez deux hommes ressortir une femme apparemment inanimée. Celle-ci s'est noyée et vous n'avez aucune information quant au temps qu'elle a passé dans l'eau. Quelle action devez-vous effectuer ?

- A. Mettre la tête de la femme en bas pour faciliter l'évacuation de l'eau
- B. Mettre en place des patchs de défibrillation
- C. Sécher le corps de la femme
- D. Effectuer 5 insufflations
- E. Coup de poing sternal

Réponse D ???

Une jeune femme de 26ans vous consulte pour une légère tuméfaction et douleur des 3e et 4e doigts de la main gauche. Ces douleurs sont apparues suite à un traumatisme mineure il y a 10 jours, et ne se sont pas améliorées.

Elle a présenté il y a quelques années un épanchement pleural, qui a été mis sur le compte d'une infection virale. Elle ne présente aucun autres symptômes à l'anamnèse par système, et n'a notamment jamais eu d'éruption cutanée au niveau du visage. L'anamnèse familiale est également négative.

A l'examen clinique, vous remarquez que les articulations interphalangiennes proximales des 3 et 4e doigts sont tuméfiées et douloureuses au niveau de la main gauche, sans limitation nette de la mobilité.

Au laboratoire, vous retrouvez une VS et une CRP légèrement augmentées. Les anticorps anti-nucléaires sont à 1:1620 (N <1:80) et des anticorps anti-Sm positifs.

Quel est votre diagnostic ?

- A. Maladie de Sjögren
- B. Maladie de Still
- C. Lupus érythémateux systémique
- D. Polyarthrite rhumatoïde
- E. Sclérodermie

Réponse C

Un patient d'une trentaine d'années se présente aux urgences car il a remarqué ce matin que sa paupière supérieure gauche tombait plus que la droite. Vous remarquez également un léger myosis de l'œil gauche, accentué dans l'obscurité. Aucun autre trouble neurologique ne ressort à l'examen clinique. Quel examen effectuez-vous ?

- A. CT cérébral
- B. IRM du cerveau et des artères du cou
- C. RAPD
- D. Fond d'œil
- E. XXX

Réponse B ? (ressemble à un Claude-Bernard-Horner)

Une jeune femme est hospitalisée après accident de voiture. Après 6 heures, elle développe une paralysie de l'hémicorps droit. A l'examen clinique vous retrouvez l'image suivante :



Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. AVC/AIT
- B. Dissection carotidienne
- C. Hémorragie cérébrale
- D. Hématome sous-dural
- E. Hématome épidural

La combinaison d'une paralysie de l'hémicorps droit et d'un syndrome de Horner gauche après un accident de voiture oriente fortement vers une dissection de l'artère carotide (option B).

Raisonnement :

Dissection carotidienne :

La dissection de l'artère carotide interne est une cause fréquente de syndrome de Horner associé à des déficits neurologiques focaux, tels qu'une hémiparésie.

Elle se produit souvent à la suite d'un traumatisme, comme un accident de voiture.

Le syndrome de Horner (ptosis, miosis, anhidrose) survient du côté de la lésion, ici à gauche, tandis que l'hémiparésie est du côté opposé (hémicorps droit) en raison de l'effet sur la circulation cérébrale.

AVC/AIT (option A) : Bien qu'un AVC puisse provoquer une hémiparésie, le syndrome de Horner associé est moins commun dans ce contexte, sauf si l'AVC implique spécifiquement le trajet des fibres sympathiques.

Hémorragie cérébrale (option C) et hématomes (options D et E) : Ces conditions peuvent provoquer des symptômes neurologiques, mais le syndrome de Horner est moins typique à moins d'une atteinte spécifique des fibres sympathiques, ce qui est rare.

Réponse B

Un patient de 65ans connu pour une goutte, une insuffisance cardiaque et une hypertension artérielle présente une douleur intense, rougeur et tuméfaction de l'hallux droit. Son traitement comprend du Lisinopril (IEC), de l'Allopurinol et un diurétique thiazidique. Il prend également de l'Ibuprofène et du Paracétamol pour des lombalgies.

Quel traitement est à l'origine de la symptomatologie de votre patient ?

- A. Lisinopril
- B. Allopurinol
- C. Thiazidique
- D. Ibuprofène
- E. Dafalgan

Réponse C

Une patiente en bonne santé habituelle se présente pour une diplopie verticale. Elle voit double quand elle regarde en bas à gauche. Quelle est la structure atteinte ?

- A. Myasthénie oculaire
- B. Paralysie du nerf abducens gauche

- C. Paralyse du nerf trochléaire droit
- D. Paralyse du muscle oblique inférieur gauche
- E. Paralyse du nerf oculomoteur droit

Réponse C

Une fille de 14ans se rend aux urgences gynécologiques suite à un test de grossesse positif. Elle est actuellement à 11 semaines d'aménorrhée et souhaite une interruption de grossesse, en revanche elle ne veut surtout pas que ses parents soient au courant.

- A. Vous effectuez une interruption de grossesse
- B. Vous attendez 3 semaines puis effectuez une interruption de grossesse si elle n'a pas changé d'avis
- C. Vous prévenez ses parents
- D. Vous la redirigez vers un centre d'aide
- E. Vous demandez l'avis en urgence au comité d'éthique (qqch du genre)

Réponse A

Vous êtes appelés avec l'équipe du SMUR pour une homme d'une cinquantaine d'années retrouvé inconscient. Arrivé sur place, vous retrouvez un homme inconscient et ne présentant pas de pouls. Une réanimation est débutée, lors de l'installation du défibrillateur, le premier tracé que vous voyez montre une activité électrique sans pouls.

Quelle est la prochaine étape ?

- A. Défibrillation
- B. Poursuite de la réanimation sans autres modifications
- C. Amiodarone
- D. Adrénaline
- E. Intubation

Réponse D

Un patient de 50ans connu pour une hypertension artérielle traitée par Lisinopril, Nifédipine et Métoprolol présente une tension à 150/95mmHg. Le laboratoire montre une kaliémie à 3.0 (norme 3.5-5.5mM).

A quel résultat vous attendez-vous ?

- A. Ratio aldostérone/rénine augmenté
- B. Ratio aldostérone/rénine abaissé
- C. Ratio aldostérone/rénine dans la norme
- D. Une augmentation isolée de la rénine

Réponse A

Une femme de 30ans présente une perte de poids, diarrhées, insomnie et hypertension légère. Le laboratoire montre une TSH à 0.2mUI/L (N : 0.45-4.5mUI/L) et une T4 libre à 360nM (N : 80-140nM).

Quel examen effectuez-vous pour appuyer votre hypothèse diagnostic ?

- A. Anticorps anti-thyroglobuline
- B. Anticorps anti-récepteur de la TSH
- C. US de la thyroïde
- D. Cytoponction de la thyroïde

Réponse B

Une femme de 26ans connue pour une hypertension artérielle traitée par Lisonopril et Nifédipine présente une tension à 150/95mmHg. Le laboratoire montre une kaliémie à 3.0 (norme 3.5-5.5mM).

Quelle est votre hypothèse diagnostic ?

- A. Sténose des artères rénales
- B. Phéochromocytome
- C. Hyperthyroïdie
- D. Syndrome de Conn (hyperaldostéronisme primaire)
- E. Acromégalie

Réponse D

Vignette 1.1. Une femme de 56ans est hospitalisée dans votre service pour une **décompensation BPCO**. Elle est également connue pour une **HTA traitée**. Actuellement elle répond bien au traitement par **Salbutamol**, **corticoïdes** et **oxygénothérapie**.

Vous êtes appelé le soir car l'infirmière la **retrouve inanimée**. Arrivé à son chevet, vous retrouvez une dame qui **ne répond pas au stimulus douloureux**. Vous n'arrivez pas à trouver son **pouls**. Que faites-vous en priorité ?

- A. Défibrillation
- B. **Débuter une RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire)**
- C. Effectuer 2 insufflations
- D. Maintenir les VAS perméables
- E. Poser une VVP

Réponse B

Vignette 1.2. Vous débutez une réanimation cardio-pulmonaire. Pendant que vous effectuez le **massage cardiaque**, un infirmier installe le défibrillateur. Le **premier tracé** montre l'image suivante :



Quel examen effectuez-vous en priorité pour poser le diagnostic le plus probable ?

- A. **ECG**
- B. Echocardiographie
- C. Coronarographie
- ?, D. Gazométrie
- E. CT thoracique

Réponse D

Vignette 1.3.

Pendant qu'elle posait la VVP, une infirmière a récupéré un échantillon de sang et a effectué une **gazométrie**. Elle vous tend les résultats suivants :

- pH ↘ 7.19 (N : 7.35-7.45)
- PaO₂ 11kPa (N : 10-13.3kPa)
- PaCO₂ ↗ 12kPa (N : 4.5-5.5kPa)
- HCO₃⁻ ↗ 32mM (N : 22-26mM)
- Na⁺ ↘ 125mM (N : 130-145mM)
- Cl⁻ 100mM (N : 95-105mM)
- K⁺ ↘ 3.1mM (N : 3.6-5.0mM)

Acidose respiratoire ← Hypoventilation

Qu'effectuez-vous pour sauver votre patiente ?

- A. Salle cathétérisme
- B. Thrombolyse IV
- C. **Ventilation mécanique 30x/min**
- D. Pose d'un drain thoracique
- E. Circulation extra-corporelle

Réponse C

Un adolescent de 13 ans se présente à votre consultation pour des douleurs au genou qui durent depuis 2 semaines. Elles sont exacerbées à l'effort. La radiographie montre :



- A. Ostéochondrite disséquante
- B. Arthrite juvénile idiopathique
- C. Epiphysiolyse
- D. Douleur de croissance
- E. Rhumatisme articulaire aigu

Réponse A

Patient d'une cinquantaine d'année, présente un syndrome grippal suivi d'un rash cutané. Il revient vous voir car quelques temps plus tard il présente de nouveau les mêmes lésions.



- A. Scarlatine
- B. Erythème toxique
- C. Erythème noueux
- D. Borréliose
- E. Syphilis secondaire

Réponse C

Institutrice de 35ans qui a commencé à travailler avec des enfants en bas âge. Elle se présente à votre consultation suite à l'apparition d'un rash cutané. Elle vous montre les lésions suivantes :



- A. VZV
- B. Eczéma
- C. Dermatite atopique
- D. Pied-main-bouche
- E. Hépatite

Réponse A

Homme de 56ans traité par Pénicilline depuis 3 jours pour une raison X. Il se présente aux urgences pour un oedème de la face et une dyspnée. Il est tachycarde à 110/min et hypotendu à 95/60mmHg.

- A. Amiodarone IV
- B. Adrénaline IM
- C. Bolus NaCl
- D. Oxygénothérapie 100%

Réponse B

Un enfant afghan de 2 ans se présente aux urgences avec sa mère. L'anamnèse est très limitée par la barrière de la langue et vous ne parvenez pas à obtenir le status vaccinal de l'enfant. Il présente de la fièvre ainsi qu'une toux aboyante et un état général diminué. Au status, il est fébrile à 38.5°C. A l'examen de la cavité buccale, vous mettez en évidence des amygdales oedématisées et couvertes d'un dépôt blanc ainsi qu'un érythème des zones amygdaliennes et pré-amygdaliennes. Au frottement léger des amygdales, un saignement est déclenché puis cesse rapidement spontanément. Les résultats de laboratoires sont les suivants:

- Hémoglobine : 88 g/L
- Plaquettes : 155 G/L
- Leucocytes : 22.3 G/L.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une angine de Plaut-Vincent
- B. Une infection à EBV
- C. Un abcès para-amygdalien
- D. La diphtérie
- E. Une angine à streptocoques

Réponse D

Une patiente de 45 ans vient chez le généraliste pour un bilan de contrôle. Elle présente des épisodes de dyspnée nocturne deux fois par semaine ainsi que lors des activités physiques.

Durant ces épisodes, elle décrit également une respiration sifflante. Elle prends occasionnellement un bêta-agoniste inhalé de courte durée d'action qui permet de soulager

rapidement ses symptômes. La spirométrie montre une VEMS1 à 85% du prédit.

Qu'est-ce que vous faites ?

- A. Vous lui conseillez d'arrêter le sport
- B. Vous prescrivez un corticoïde pendant 7 jours
- C. Vous prescrivez un anti-leukotriene
- D. Vous prescrivez un bêta-agoniste de longue durée d'action, à prendre régulièrement
- E. Vous lui prescrivez un corticoïde inhalé et un bêta-agoniste de longue durée d'action

Réponse E

Patient de 32 ans consulte car il est inquiet. Son frère (35 ans) est décédé d'une mort subite il y a quelques jours. Le patient paraît en bonne santé, l'examen est normal hormis un souffle proto-méso-systolique, purement systolique lorsqu'il se penche en avant.

- A. Bicuspidie aortique
- B. Prolapsus mitrale
- C. Dissection
- D. CMH

a. Bicuspidie aortique
Souffle : La bicuspidie aortique est souvent associée à un souffle systolique dû à une sténose aortique, mais ce souffle est généralement mieux entendu au deuxième espace intercostal droit et irradie vers les carotides.
Antécédents familiaux : Bien que la bicuspidie aortique puisse être héréditaire, elle est moins directement associée à la mort subite comparée à la CMH.
Souffle qui change en se penchant en avant : Ce phénomène est moins caractéristique de la bicuspidie aortique.

b. Prolapsus de la valve mitrale
Souffle : Le prolapsus mitral est souvent associé à un souffle de régurgitation mitrale, typiquement entendu au foyer mitral (5e espace intercostal, ligne médioclaviculaire). Ce souffle est généralement un clic suivi d'un souffle holosystolique.
Souffle qui change en se penchant en avant : Le prolapsus mitral est moins susceptible d'entraîner un changement significatif du souffle avec cette manœuvre.
Antécédents familiaux : Le prolapsus mitral peut être familial, mais il est moins lié à la mort subite que la CMH.

c. Dissection aortique
Présentation clinique : La dissection aortique est souvent associée à une douleur thoracique aiguë, déchirante, irradiant vers le dos, et non à un souffle à l'auscultation cardiaque. Le souffle entendu en cas de dissection serait généralement dû à une insuffisance aortique secondaire, non un souffle systolique.
Souffle : Un souffle systolique n'est pas caractéristique de la dissection aortique.

Antécédents familiaux : Bien que certaines conditions prédisposant à la dissection aortique puissent être familiales (ex. : syndrome de Marfan), la présentation clinique ne correspond pas.

En résumé, bien que certaines de ces conditions puissent présenter des souffles à l'auscultation, aucune ne correspond aussi bien que la CMH à l'association entre un souffle systolique modifié par des manœuvres et un antécédent familial de mort subite.

Réponse D

Patiente d'une trentaine d'années (mais je crois que même pas, genre elle avait 28 ans), fumeuse, IMC >28, se présente pour une nécrose des orteils.



- A. Emboles de cholestérol
- B. AOMI
- C. Polyangéite
- D. Insuffisance veineuse

Réponse ???

A quoi sert la scintigraphie rénale dynamique (vignette où on explique avant les investigations pour un enfant en bas âge avec RVU, mais on s'en fout pour la question) ?

- A. Fonction rénale de chaque rein individuellement
- B. Fonction rénale globale
- C. La vascularisation de chaque rein
- D. Evaluation des lésions rénales

Réponse A

Enfant de 6 ans qui présente une énurésie. Il n'a jamais été propre la nuit, de jour il est propre depuis ses 3 (?) ans. La maman consulte chez vous car elle ne sait plus quoi faire. Le pauvre gosse ne veut pas aller chez son pote pour une pyjama party car il a peur de faire pipi au lit. Que faire ?

- A. Thérapie psycho-dynamico-comportementalo-sociale
- B. Bilan entrée-sorties et restriction hydrique dès 17h
- C. Calendrier des mictions et thérapie comportementale (appareillage etc)
- D. On donne des anti-diurétiques (Desmopressine)

Réponse B ou C ?

Je me rappelle plus de la vignette, mais radio du coude (a peu près comme celle-là, mais c'était discret)



- A. Radio normale
- B. Luxation tete radiale
- C. Fracture de la tete radiale
- D. ...

Réponse C

Vignette d'un enfant de 2 ans avec une sinusite et ils demandaient quel était le sinus concerné.

- A. Ethmoidal
- B. Sphénoïde
- C. Frontal
- D. Maxillaire

Réponse A ? Mais plus sûr des propositions ni de l'âge...

Une femme de 40 ans présente une légère dyspnée progressive à l'effort. Une Rx est effectuée ⇒ Infiltrat hilair. La biopsie d'un nodule cutané montre un granulome épidermoïde. Quelle pathologie présente-t-elle?

- A. Lymphome malin
- B. Tuberculose
- C. Sarcoïdose
- D. Cancer bronchique
- E. Vasculite de Churg Strauss

Réponse C